猫咪腹泻·深度科普与解决大全（v2 修订）

基于权威兽医信源的系统指南 + 多多（6月龄·公·狸花猫）专属排查与调整方案

版本 v2 | 生成日期 2026-10-15 | 约 1.6 万字 | 含 8 张图表 | v2 修订：补全排查图、茶匙换算、过量量化、喂食决策树、一锅菜谱、人猫共吃 5 食谱、京东京造评估、时间线修正

阅读须知（必读）：本文为面向养猫人的**科普与居家管理参考**，内容来自公开权威兽医资料并标注来源，**不能替代执业兽医的诊断与治疗**。猫咪病情多变，出现血便、呕吐、沉郁、脱水、体重下降等警示信号，或腹泻持续不缓解，请及时就医。文中"京东京造"等具体商品仅为结合多多个案的客观评估，**不构成推荐或背书**。

目录

Part A 知识大科普

A1 什么是腹泻（含粪便评分图）

A2 四大病理机制（图解）

A3 急性/慢性 + 小肠/大肠鉴别

A4 常见病因谱

A5 年龄分层

A6 急诊红线

Part B 解决方法大全

B1 标准化排查路径（决策树·完整版）

B2 饮食调整：原料与理论 + 量化

B3 水分管理

B4 过渡换粮法（含"只有新粮"情形）

B5 益生菌 / 益生元

B6 常用药物机理与红线

B7 居家护理与记录表

B7.5 别的猫吃没事、他一吃就拉？

B8 人猫可共享的恢复餐（5 个一锅菜谱）

Part C 多多专属方案

C1 个案时间线复盘（已修正）

C2 研判（事实/推断/建议）

C3 14天调整计划（含强制换粮）

C4 一页式快速排查卡

C5 怎么喂：定时 vs 自由 + 决策树

参考文献与来源

Part A • 知识大科普

A1 什么是腹泻

定义：腹泻是粪便性状变稀、排便次数或总量多于正常，本质是"肠内容物通过过快 + 水分/电解质吸收减少"。VCA Animal Hospitals 明确指出：**腹泻本身不是疾病，而是众多疾病的共同症状**；即使由轻症引起，若不及时处理也可能因脱水等变得严重（VCA Animal Hospitals, "Diarrhea in Cats"）。

健康猫的粪便应为**成形、分节、捡起不散。**判断是否腹泻，看三件事：**形态（软/糊/水）、频率（是否明显增多）、是否带血/黏液。**若频繁液状或半液状粪便**持续超过 2 天**，应咨询兽医（VCA）。

图1 • 粪便性状评分谱（1–7 级，猫用改编版）



健康区间偏软 软便腹泻严重腹泻 猫的理想粪便约在 2–3 级；4 级起属"软便"，5–7 级属腹泻。居家每天铲砂看一眼即可自评。

> 评分方法（居家可用）：每天记录便便落在哪一级、次数、颜色、是否带血/黏液。连续 3 天 ≥5 级即算"腹泻在活动"，应进入 Part B 排查流程。

A2 腹泻的四大病理机制（为什么"拉稀"）

无论病因是什么，腹泻最终都通过以下四类机制之一（或组合）发生（catmd.ca, "Diarrhea"）：

① 渗透性	② 分泌性	③ 渗出性	④ 动力性
Osmotic	Secretory	Exudative	Motility
未消化溶质 把水"拉"进肠腔	肠壁主动 "吐"出水/电解质	肠黏膜破损 漏血/蛋白/脓液	蠕动过快 来不及吸水
例:吃多/ 不耐某成分	例:细菌毒素/ 炎症(IBD)	例:寄生虫/ 细菌感染/溃疡	例:应激/ 肠易激

真实病例常为多种机制叠加；偷吃变质虾头即"渗透+分泌+渗出"三联击。

> 理论要点：**渗透性腹泻在禁食/减量后会明显减轻**（因为少了"未消化溶质"）；**分泌性/渗出性腹泻禁食也难停**，往往提示感染或炎症，需要就医。这条规律是居家判断"能不能先观察"的关键。

A3 急性/慢性之分 + 小肠/大肠鉴别

急慢性：腹泻 **≤2–3 周**多为急性（食物、寄生虫、感染、应激）；**持续 >3 周，或一个月内间歇性反复**即归为慢性（Expert Cat Care；SpectrumCare, "Chronic Diarrhea in Cats"）。慢性不等于严重，但意味着需要系统排查，而非仅靠禁食。

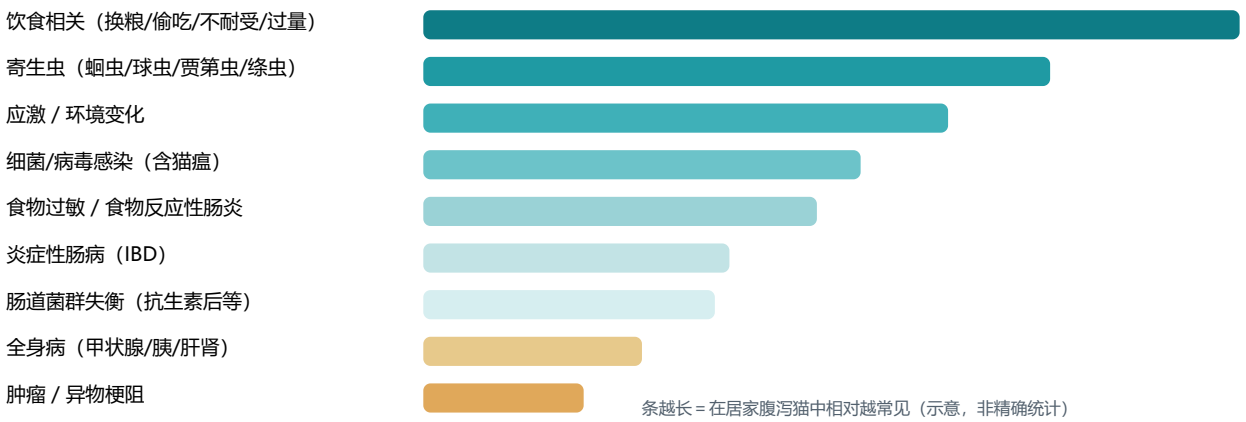
定位（小肠 vs 大肠）是兽医缩小病因范围的第一步。看大便"长什么样"就能初判（Small Animal Internal Medicine, 教科书 Table 11-1；Expert Cat Care）：

特征	小肠性腹泻（Small bowel）	大肠性腹泻（Large bowel / 结肠）
排便量	正常或增多	减少（每次少量）
排便频率	正常或轻度增多	明显增多（频繁跑砂盆）
黏液	通常无	常有（果冻状）
血	若有→黑便/柏油样（消化过）	常有鲜红血（hematochezia）
里急后重/努责	无	常有
呕吐	可能出现	可能出现
体重下降	**常见**	少见
典型病因	食物不耐受、IBD、寄生虫(蛔虫/绦虫)、胰/甲状腺/肝肾等全身病	结肠炎、应激、球虫/贾第虫、部分食物过敏、直肠异物

> 多多个案提示：**间歇性软便、精神食欲好、无血无黏液无消瘦**——更接近"轻度、以饮食/菌群相关为主"的模式，倾向于大肠性或轻度小肠性，暂未指向严重全身病。但仍需按慢性流程管理（见 Part C）。

A4 常见病因谱（相对常见度，示意排名）

下图按"在居家猫中出现的大致相对频率"排序，**仅供优先级参考，非流行病学精确比例。**注意：小猫（如多多）感染性/饮食性占比更高。



A5 年龄分层：幼猫 / 青年猫 / 老年猫

年龄段	更常见病因	特别提醒
幼猫（<6月，如多多）	寄生虫、感染、换粮/偷吃、先天性消化弱、低血糖风险	免疫系统未成熟；**禁食耐受差，小猫别长时间断食**；脱水更快
青年/中年（1–7岁）	食物过敏（食物反应性肠病）、IBD、应激、异物	慢性病开始显现，需做食物排查试验
老年（>7岁）	慢性肾病、甲亢、肠癌、慢性胰炎、EPI	"吃多还瘦+一直拉"要查甲功/肾/胰

A6 急诊红线：何时必须就医

出现以下任一，不要在家硬扛，尽快就医：

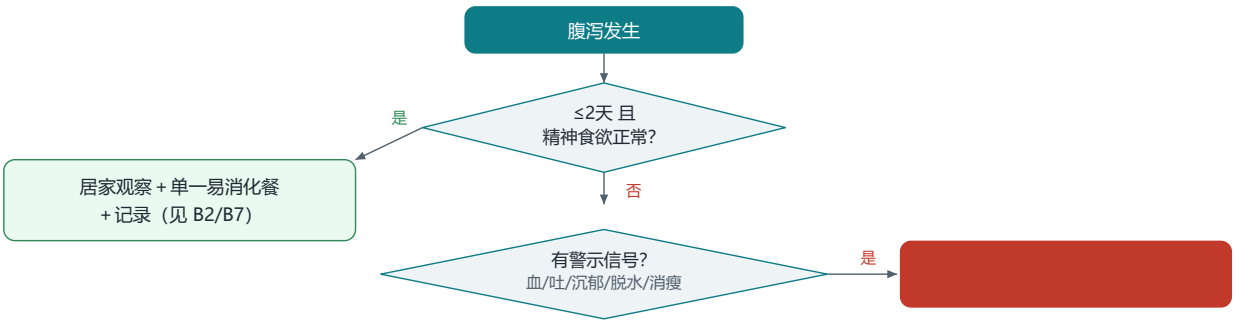
- **血便**（鲜红或黑柏油样）或大量黏液
- **呕吐**（尤其频繁、带黄绿胆汁、带血）
- **精神沉郁**：嗜睡、躲藏、反应迟钝、不爱动
- **脱水**：提起颈后皮肤回弹慢、牙龈干、眼窝凹陷
- **体重下降 / 消瘦**、食欲明显减退或拒食
- 腹泻 **持续 >2 天无改善**，或 **反复发作超 3 周**
- 疑似**吃了异物 / 有毒物**（葱蒜、葡萄、巧克力、药）
- **小猫（<6月）腹泻伴精神差**——风险高于成年猫

来源：VCA Animal Hospitals；SpectrumCare；猫后苑（HK）。

Part B • 解决方法大全

B1 标准化排查路径（决策树 • 完整版）

把"看到腹泻→该做什么"固化成一条可执行的链路。下图覆盖**所有分支**（居家观察 / 急诊 / 小肠·大肠定位 / 寄生虫 / 食物试验 / 进一步检查 / 换粮偷吃情形），文字步骤紧随其后。



立即就医（急诊） 否 大便特征定位? 小肠型 小肠型：量大/消瘦/呕吐 → 查全身病：血检·甲功·胰·B12·腹腔超声 大肠型 大肠型：频繁/黏液/鲜血 → 粪检(注意假阴性)＋食物排查试验 2–4 周 仍无效（>2–4周）→ 粪PCR / 肠镜活检 / 专科 **贯穿所有分支的两件事：** ① 换粮/偷吃/只有新粮? → 见 B4「只有新粮怎么办」与 C5 喂食决策；幼猫**别长时间断食。** ② 全程记录便便分级（目标 2–3 级）、饮食、体重；带**当天新鲜粪便**就医以提高检出率。

居家可执行步骤（精神好、无警示信号时）：

1. **记录**：便便分级、次数、颜色、血/黏液、进食量、精神状态（用 B7 表格）。
2. **暂停"可疑新东西"**：停零食、停新粮、停一切人食；回到"已知不拉"的饮食（若老粮已无，按 B4 处理）。
3. **单一易消化餐**：见 B2 居家温和餐；少食多餐（多多尤要）。
4. **补水**：多放水碗/流动水/肉汤（无盐无葱蒜），见 B3。
5. **观察 24–48 小时**：若升级为警示信号→就医；若好转→维持并缓慢过渡。
6. **若 >2 天无改善或反复**：带"当天新鲜粪便样本"就医，进入专业排查（B1 树）。

B2 饮食调整：原料与理论＋量化（不推品牌，只讲该有什么、为什么、多少）

用户要求：**不推荐具体品牌商品**，只说明主要原料需要什么、理论依据是什么。以下按"原料 → 理论支持 → 日常哪里买得到 → 给多多多少"展开。

原料（日常可购）	理论支持	给多多多少（6月/约3kg）
鸡胸肉（超市/菜场，蒸熟，去皮去脂）	高消化率**动物蛋白**、低抗原性、低脂。未消化蛋白进入结肠被发酵→产气+渗透压↑→稀便；易消化的优质蛋白减少"漏网溶质"。腹泻期建议"高消化蛋白+低脂肪"（Radiokop Vet）。	作主食基底，按重量占餐量主体；与南瓜/少量碳水搭配
南瓜（菜场，蒸熟打成泥，**无任何添加**；贝贝南瓜亦可，见下）	含**可溶性+不可溶性纤维**。可溶性纤维在肠腔吸水成凝胶→固化稀便、减慢 transit；发酵产**短链脂肪酸(SCFAs)**养结肠细胞、养有益菌（prebiotic）。多个兽医科普一致推荐（Biology Insights；CatSphere；ScienceInsights）。	**≤1 茶匙/天（≈5g），分 2 餐**；多多从 ¼–½ 茶匙/餐起。过量反致胀/泻（见"过量红线"）
白米饭 / 米汤（少量）	低敏、易消化碳水，供能且略"收敛"，是经典 bland diet 组分。猫非必需碳水，**仅恢复期少量**作粘合/能量。	占小比例（约餐量10%）；非主食
熟鸡蛋黄（蒸熟，适量）	含卵磷脂、维生素与易吸收营养；**熟**制避免生蛋清中抗生物素蛋白(avidin)干扰。不过量、确认不过敏。	隔天半个蛋黄拌入；观察便便
凉白开 / 无盐无葱蒜肉汤	腹泻丢水丢电解质；猫渴感弱、吃干粮更易缺水。增加液体摄入防脱水、软化 transit（VCA：腹泻猫必须保证饮水）。	多置水碗 + 流动水；肉汤每日少量
益生菌（含特定菌株，见B5）	菌株特异性地恢复菌群、竞争病原、产 SCFAs、提升肠道 IgA。	按说明拌入；水温≤40℃以免杀活菌
洋车前子壳粉（可溶性纤维，极少量）	高纯度可溶性纤维，大肠性腹泻时形成凝胶固化粪便；需充分泡发。**用量需兽医指导**，过量反致胀/泻。	极少量（牙签尖）泡水后拌入；非必需

茶匙到底是多少（按克数）？ 1 茶匙(teaspoon, tsp)≈5 mL；南瓜泥/肉泥密度接近 1 g/mL，故 **1 茶匙 ≈ 5 克。**常用换算：

量	近似体积	近似重量（南瓜/肉泥，密度≈1g/mL）
¼ 茶匙	1.25 mL	≈ 1.25 g
½ 茶匙	2.5 mL	≈ 2.5 g
1 茶匙(tsp)	5 mL	≈ 5 g
1 汤匙(tbsp)	15 mL	≈ 15 g

注：干料（如洋车前子壳粉）更轻，同体积克数更小；湿泥按上表估即可。

过量红线（量化清楚）：

项目	多多合理量	过量信号 / 红线
干粮 / 日	目标 50–70 g（分 3–4 餐）	持续 >80 g/日 或 单餐吃撑 → 软便/吐
单餐（4 餐制）	13–18 g	单餐 >25 g 且便便变软 → 立即减
南瓜 / 日	≤ 1 茶匙(≈5 g)，分 2 餐	**>2 茶匙(≈10 g)/日 → 胀气、反致泻**
鸡胸肉（作主食管）	占餐量主体，按重量配南瓜/少量碳水	纯肉无碳水长期→营养不全；作主食需搭配
零食 / 猫条	恢复期尽量 0	任何猫条都可能诱发（见 B7.5）

判断"过量"的黄金标准：**便便从 2–3 级掉到 4 级及以上、或腹胀/呕吐** = 这餐/这天多了，下次减 10–15%。

居家"温和餐"参考配方（腹泻活动期 / 过渡期） + 一锅出做法

组成：蒸熟鸡胸肉（去脂）70% + 熟南瓜泥 20% + 软米饭/米汤 10% + 少许无盐肉汤调湿度。每日分 3–4 餐、每餐少量（契合多多"吃多就拉"体质）。

一锅出做法（鸡胸肉 + 贝贝南瓜同锅蒸）：鸡胸肉 1 块（约 80–100g，去皮去脂） + 贝贝南瓜 100g（去皮去籽切小块）放入蒸锅/盘，**水开后蒸 12–15 分钟**至肉熟透、南瓜软烂；取出鸡肉撕碎/切小丁，南瓜压成泥，按 7:3 混合后拌少许蒸出的原汤调湿度即可。**人猫可同锅：人那份盛出后自行加酱油/椒盐；猫那份保持原味无盐无葱蒜。**

理论：高消化动物蛋白（少渗漏溶质）+ 可溶性纤维（吸水固化）+ 低脂肪（减轻负担）+ 少量易消化碳水（能量）+ 少食多餐（降低每餐渗透压负荷）。便便回到 2–3 级稳定 3–5 天后，再按 B4 缓慢过渡到常态饮食。

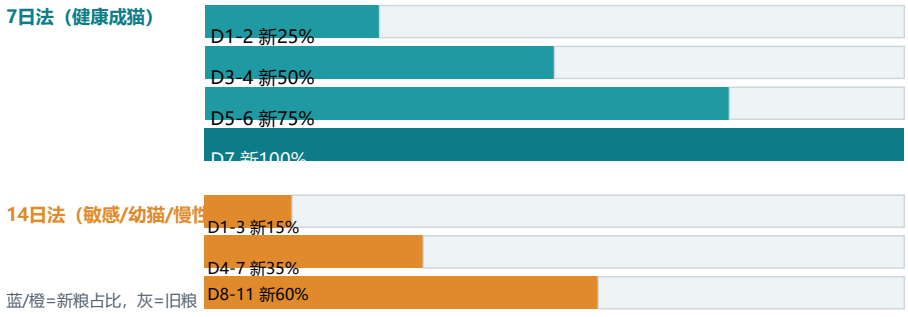
> **绝对避免：**高盐/调味人食、生肉生鱼、虾壳虾头、牛奶（猫乳糖不耐）、高脂、葱蒜（溶血）、葡萄/巧克力、突然换粮、多种零食轮换、人用止泻药（多数对猫有毒，须兽医处方）。

B3 水分管理

- **为什么重要**：猫祖先来自干旱环境，渴感弱；吃干粮猫普遍慢性缺水。腹泻时水分从肠道大量丢失，**脱水是幼猫最危险的并发症。**
- **怎么做**：家中≥2 个水碗分散放置；用流动饮水机提升兴趣；湿粮/肉汤提升摄入；腹泻期可少量多次补电解质（兽用口服补液盐，遵医嘱）。
- **自测脱水**：提颈后皮肤，松手后 1 秒内回弹为正常；回弹慢、牙龈干、眼窝凹 = 脱水，就医。

B4 过渡换粮法（7 日 / 14 日） +「只有新粮、老粮买不到」情形

猫肠道菌群对旧粮配方有"记忆"，骤换→菌群来不及适配→渗透压失衡/发酵→软便。权威营养学会与多篇兽医科普均推荐**渐进换粮**；肠胃敏感/幼猫/慢性肠病者拉长到 **10–14 天**（台湾宠物营养保健食品学会；东北网引《2026中国宠物行业白皮书》；氧宠博士）。



便便是推进依据，不是日历：出现软便→停在当前比例稳住 2–3 天；加重→退回上一档甚至回旧粮；一切正常才进下一档。敏感猫实际常需 10–14 天，慢不是失败。

⚠️ 只有新粮、老粮买不到（多多当前情形）

多多目前"老粮只剩一点、买不到了、只有新粮（京东京造）"，无法做经典的旧:新混合过渡。处理原则：

1. **榨干最后一点老粮做缓冲**：若还剩少许老粮，把它与**大量新粮**按 老 20%:新 80% 先混 2–3 天，再 0:100，相当于用极少老粮"稀释"新粮冲击（比直接全换温和）。
2. **若老粮彻底没有 → 必须全换新粮时，用"温和餐桥接法"降低刺激**：先以 B2 的鸡胸肉+南瓜温和餐为主食 2–3 天，让肠道休息；随后把新粮**碾碎/泡软**少量拌入温和餐，从 15–25% 新粮开始，按 14 日法的节奏（但用"新粮占温和餐比例"来推进）缓慢加到全量。
3. **全程少食多餐 + 南瓜 binder（¼–½ 茶匙/餐）**，每天记便便分级。
4. **红线**：全换新粮后若便便 ≥5 级持续 >2 天、或呕吐/沉郁 → 立即就医，并考虑改用兽医处方胃肠粮或低敏粮（见 B7.5 / C2）。

核心：不能渐混时，用"温和餐桥接 + 泡软新粮 + 慢比例"替代"旧:新混合"，目标同样是给肠道菌群适应期，而不是硬切。

B5 益生菌 / 益生元

事实层（有研究支持）

猫咪腹泻相关益生菌证据最强的是

特定菌株

：*Enterococcus faecium* SF68。随机对照试验显示，服 SF68 的猫腹泻评分显著低于安慰剂组（P=0.0058，PubMed 29291771, 2017）；该菌株在收容所猫、慢性非特异性腹泻猫、幼猫中均被证实可改善粪便质量/预防腹泻（Purina FortiFlora 资料；AAFP 会议综述）。*Saccharomyces boulardii*（布拉氏酵母）在人或犬猫腹泻中亦有应用（氧宠博士提及）。

推断层

多多属"菌群偏弱 + 急性炎症后未完全恢复"，补充

有研究背书、标明菌株与活菌数

的益生菌，理论上有助于菌群重建与肠黏膜修复，但属于辅助而非治疗根本病因。

建议层

选购时认"菌株名 + 活菌数 CFU + 有临床研究/兽医推荐"，不迷信"含益生菌"泛称；AAFP 综述提醒部分产品

实际活菌不达标

，质量参差。拌入食物、水温≤40℃。

B6 常用药物机理与红线

类别	机理	居家红线
蒙脱石类（吸附剂）	物理吸附毒素/水分、保护黏膜	需兽医指导用量；与益生菌/药隔开 2h 服，否则互相吸附失效
益生菌（见 B5）	恢复菌群、竞争病原	选对菌株；非万能，无效要查因
抗生素（如甲硝唑）	杀厌氧病原/抗炎（IBD）	**必须兽医处方**；滥用伤菌群；幼猫剂量敏感
驱虫药	清除寄生虫	即便粪检阴性，慢性软便兽医常仍建议"经验性驱虫"；按体重给药
人用止泻药	—	**多数对猫有毒（如洛哌丁胺可致中枢抑制），严禁自用**

红线总结：任何人用止泻/抗菌药都不要给猫自行使用；药物仅限兽医处方。居家能做的=饮食管理 + 补水 + 记录 + 益生菌辅助。

B7 居家护理与记录表

记录是给兽医最有价值的素材。建议连续记 2 周：

日期	便便分级(1-7)	次数	颜色/血/黏液	当日饮食	精神/食欲	备注
—						
—						
—						

同时每周称一次体重（幼猫用厨房秤），毛色/体重是比便便更客观的"长期健康指标"。多多"发黄"建议同步观察体重与营养摄入。

B7.5 别的猫吃罐头/猫条没事，多多一吃就拉？是肠胃弱，还是量大？

多多 4 个多月吃罐头/全价湿粮就腹泻，当时以为恢复、后来才察觉是猫条或罐头导致的——这类"别人吃没事、他一吃就事"很典型，原因通常是**多重叠加**，而非单一：

可能原因	机制	对应多多的情况
先天/幼期肠道耐受弱（"玻璃胃"）	菌群定植弱、消化酶与黏膜屏障未稳；幼期"很饿→暴食→软便"进一步损伤耐受力	高度符合：他从小吃多就拉、减量才正常
食物不耐受（非过敏）	剂量依赖：某种成分（胶质增稠剂、动物消化物、鱼/禽脂肪、特定蛋白）超过他肠道处理能力即泻，**与"别的猫"无关**	罐头/猫条常含卡拉胶、瓜尔胶、诱食剂、较高脂肪
单次吃得偏多	猫条/罐头适口性高→他容易一次吃超量→渗透性腹泻	需结合"吃多就拉"的体质判断
添加剂/高脂刺激	零食类脂肪与风味剂偏高，敏感肠易激	猫条尤甚
菌群未建立	幼猫菌群本就脆弱，湿粮/零食改变更快	符合年龄

结论：更可能是"**敏感肠 + 不耐受（剂量/成分依赖）+ 可能吃多**"的组合，**不一定是"过敏"**。过敏通常伴随瘙痒/呕吐且微量即发；他主要是腹泻且"吃多/特定零食"诱发，更偏不耐受。处理：**恢复期严格停猫条与罐头**，待肠道稳定后若想尝试湿粮，用"单一蛋白、无胶质增稠剂"的处方/低敏湿粮，从极少量（指甲盖大小）开始、3–5 天观察，逐步加量——这本身就是 B1 树里的"食物排查试验"。

B8 人猫可共享的恢复餐（5 个一锅出菜谱）

以下食材对**猫恢复**与**人营养**都友好（ lean 蛋白 + 可溶性纤维 + 补水）。**铁律：猫那份必须原味——无盐、无葱蒜、无油、无调味；人那份盛出后再自行加盐/酱油/香料。**葱蒜类对猫溶血有毒，务必分锅前就分开。

① 鸡胸肉 + 贝贝南瓜 一锅蒸（最基础）

食材：鸡胸肉 1 块（约 100g）、贝贝南瓜 100g（去皮去籽切块）。**做法**：同盘水开后蒸 12–15 分钟，肉熟南瓜烂；肉撕丁、南瓜压泥，按 7:3 混合，拌少许原汤。**猫**：原味直接吃；**人**：蘸酱油/椒盐。**为何好**：易消化动物蛋白 + 可溶性纤维固化便便，一锅出零额外厨具。

② 鸡胸肉南瓜小米粥（肠胃温和）

食材：鸡胸肉 80g（剁碎）、贝贝南瓜 80g（泥）、小米 30g。**做法**：小米先煮 10 分钟，加鸡肉碎与南瓜泥再煮 8 分钟成粥。**猫**：少量（小米作 binder，非必需，猫不需谷物但恢复期少量无妨）；**人**：正常一碗，可加蛋/青菜。**为何好**：温热、好消化、补水分。

③ 全熟水煮蛋 + 南瓜泥（高蛋白）

食材：鸡蛋 1–2 个、贝贝南瓜 80g。**做法**：鸡蛋冷水煮 10 分钟全熟；南瓜蒸/煮烂压泥。**猫**：蛋黄 + 极少量蛋白（熟蛋白 OK，不过量）；**人**：全蛋。**为何好**：蛋黄卵磷脂/维生素助恢复，人猫同补蛋白。

④ 鸡胸肉胡萝卜冬瓜清汤（补水优先）

食材：鸡胸肉 100g、胡萝卜 30g、冬瓜 50g（均切块）。**做法**：清水煮 15 分钟成清汤，肉菜捞出。**猫**：喝无盐清汤 + 吃肉与少许冬瓜胡萝卜（冬瓜性凉、少量）；**人**：喝汤吃肉可加盐/葱（猫那份先捞出再调味）。**为何好**：腹泻期补水补电解质最直接。

⑤ 鸡胸肉 + 南瓜 + 白菜 一锅炖（饱腹版）

食材：鸡胸肉 100g、贝贝南瓜 100g、白菜叶 50g。**做法**：鸡肉先炖 8 分钟，下南瓜再 5 分钟，最后下白菜 2 分钟。**猫**：肉 + 南瓜 + 少许白菜（白菜少量，熟透）；**人**：整锅加盐/生抽。**为何好**：一锅出、份量足，猫得蛋白+纤维、人得整顿饭。

以上 5 款均可"人猫同锅、分碗调味"。恢复关键食材就三样：**鸡胸肉（优质蛋白）、贝贝南瓜（可溶性纤维）、足量饮水。**零食/猫条/罐头在恢复期内一律不共享。

Part C · 多多专属方案

C1 个案时间线复盘（已修正顺序）

时间	事件	解读
幼年期	很饿→暴食→软便；减量后正常才打疫苗	先天/喂养不规律致肠道耐受力偏弱，"吃多就拉"体质
4 个月+	吃罐头/全价湿粮后出现腹泻；当时以为恢复，后察觉是猫条/罐头导致	早期即对湿粮/零食（胶质、高脂、诱食剂）敏感，佐证"玻璃胃"
约 1 个月前（先）	**打第 2 针疫苗**	疫苗轻微应激，免疫系统波动
其后（后）	**偷吃垃圾桶虾头** → 腹泻开始	虾头诱因叠加：几丁质+组胺+高钠+细菌（见 A2 三联击）
此后 ~1 个月	持续拉稀（间歇性），精神尚可、活蹦乱跳	急性肠炎后未完全平复，或转食物反应性/慢性
近期	就医 + 粪检无异常 + 已驱虫；目前定量三餐但仍拉稀	基本排除寄生虫/传染病；非紧急，但已超慢性阈值(>3周)
当前	老粮只剩一点买不到、只有新粮（京东京造0谷物6肉8果蔬）；计划继续吃	面临"强制换粮"，需按 B4 桥接法处理

C2 研判（事实 / 推断 / 建议 三层）

事实层（已确认）

①公猫约6月；②间歇性腹泻1月余、精神好、粪检阴性、已驱虫；③幼期"吃多就拉"、4月+吃湿粮/猫条腹泻；④打疫苗在先、偷吃虾头在后；⑤定时三餐但仍拉稀；⑥老粮将尽、新粮为京东京造 0谷物6肉8果蔬，计划续吃。

推断层

①寄生虫/传染病基本排除；②核心为"幼期敏感肠＋虾头诱发炎症未愈/食物反应性"；③对湿粮/猫条的不耐受已被多次验证；④京东京造"0谷物"有利（降植物抗原），但"6肉8果蔬"品种多、对敏感肠未必更优；⑤长期偏低喂食可能营养/水分不足，或关联毛色偏黄。

建议层

①维持定时、改

少食多餐

，不盲目再减量；②用 B2 温和餐桥接强制换粮；③南瓜 binder＋补水＋有研究背书的益生菌；④停猫条/罐头；⑤记录 2 周；⑥若 >2 周仍反复或出现警示→带新鲜粪便复查（粪PCR/B12/食物试验/低敏粮评估）。

C3 多多的 14 天调整计划（含强制换粮）

阶段	做法	目标
第1–3天	以 B2 鸡胸+南瓜温和餐为主；新粮（京东京造）碾碎泡软，按 15–25% 拌入；若剩老粮则老20:新80 混；每餐拌 ¼–½ 茶匙南瓜；停零食；4 餐制	肠道休息＋给菌群适应期，不硬切
第4–7天	温和餐比例降、新粮占比升至 35–50%；南瓜维持 ½ 茶匙/餐；观察便便回 3–4 级	便便成形、稳定
第8–11天	新粮占 60–75%，其余温和餐；仍 4 餐	逐步衔接新粮而不刺激
第12–14天	评估：稳→维持并缓慢把总量提到合理区间(50–70g/日，分3–4餐)；不稳→就医做食物试验/粪PCR/考虑低敏粮	建立长期可维持方案

关于"日总量"：6 月龄、约 2–3kg 的猫，干粮日需参考约 50–70g。多多目前偏少，正确方向不是再减，而是在**不撑着**的前提下，用易消化高蛋白＋纤维＋少食多餐把总量稳回合理区间，同时观察体重与毛色。

C4 一页式快速排查卡（可打印）

多多•腹泻快速排查卡

身份：公猫·约6月·狸花猫（疑彩狸/黄狸）·日需约50–70g干粮·商品干粮（京东京造0谷物6肉8果蔬）·定时多餐

当前状态：间歇性拉稀1月＋、精神好、粪检阴性、已驱虫、无血/无吐/无消瘦；疫苗在先、虾头在后

---

① **每天做：**铲砂看便便分级(目标2–3级)＋记饮食＋称水碗；每周称体重。

② **怎么喂：定时少食多餐（4餐，每餐13–18g）**，**不要自由采食**（他吃多就拉）；南瓜 ¼–½ 茶匙/餐拌入；老粮尽则按 B4 桥接法换京东京造。

③ **补水：**多水碗＋流动水＋肉汤，防脱水。

④ **益生菌：**选"标明菌株(如E. faecium SF68)+活菌数"的产品，≤40℃拌入。

⑤ **停一切：**猫条、罐头、人食、虾壳虾头、牛奶。

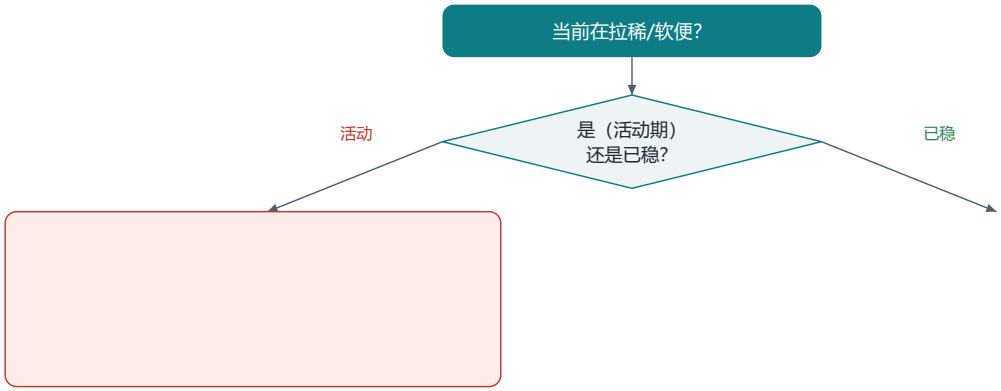
⑥ **立刻就医（任一）：**血便/黑便、呕吐、沉郁、脱水(提皮回弹慢)、消瘦拒食、>2天无改善或反复超3周。

⑦ **复查时点：**按本卡执行 2 周仍反复→带**当天新鲜粪便**就医，查粪PCR/B12叶酸/食物排查试验。

注：本卡为居家管理备忘，不替代兽医诊断。毛色偏黄建议同步关注体重与营养摄入，必要时体检。

C5 怎么喂：定时 vs 自由 ＋ 决策树（多种情况）

结论先行：多多应"定时少食多餐"，不要自由采食。理由：他的病史是"吃多就拉"，自由采食=随时能吃=容易过量→反复软便；定时能把每餐渗透压负荷压低、便于观察"哪餐后拉肚子"反推诱因。



活动期（拉稀中） → 定时 4 餐，每餐 13–18g → 不加新零食； + 南瓜 binder → 按便便分级调量（见右表） → ≥5级超2天 / 警示 → 就医 **已稳（2–3级≥1周）** → 维持定时，可微增 5–10% → 想转自由采食？先观察 2 周无反复且猫不暴食 → 才可考虑；否则继续定时 **如何判断"量是否合适"：**便便 2–3 级且精神好 = 量 OK；4 级（偏软） = 维持不增 + 南瓜；5–7 级 = 减 10–15% 或回上一稳定量；体重下降 = 就医。 自由采食仅适合"天生自控、长期便便正常"的猫；多多当前不符合，强行自由 = 复发风险高。

给多少的具体数：6 月龄约 2–3kg → 干粮日需 **50–70g。**若 4 餐：每餐 **13–18g**；若 3 餐：每餐 **17–23g。**多多现在"定量三餐但还是拉"，可改为 4 餐并把单餐量下调一档（如每餐 15g），同时加南瓜 binder 观察——**关键看便便反馈，而非死守克数。**

参考文献与来源

- VCA Animal Hospitals. *Diarrhea in Cats*（定义/病因/严重性/诊断/治疗/预后）. 访问 2026-10-15.
- catmd.ca. *Diarrhea in Cats*（病理生理分类：渗透/分泌/渗出/动力；小肠vs大肠鉴别；病因）. 访问 2026-10-15.
- Expert Cat Care. *Why Does My Cat Have Diarrhea? Investigations & Treatment*（急慢性定义、小肠/大肠表、年龄分层）. 访问 2026-10-15.
- SpectrumCare. *Chronic Diarrhea in Cats*（慢性≥3周或一月内反复；检查路径；警示信号）. 访问 2026-10-15.
- Small Animal Internal Medicine（教科书 PMC7151799）. Table 11-1 小肠 vs 大肠腹泻鉴别. 访问 2026-10-15.
- Torres-Henderson C, et al. *Effect of Enterococcus faecium SF68 on GI Signs and Fecal Microbiome in Cats Administered Amoxicillin-Clavulanate.* Top Companion Anim Med. 2017;32(3):104-108. PMID: 29291771（RCT，P=0.0058）.
- Purina Pro Plan Veterinary Diets. *Feline FortiFlora* 产品资料（SF68 对慢性腹泻/幼猫腹泻证据）.
- AAFP（catvets.com）会议综述. *Probiotics in cats*（证据最强于GI综合征；产品质量参差）. 访问 2026-10-15.
- Biology Insights / CatSphere / ScienceInsights / PetsCare. *Pumpkin for cats diarrhea*（可溶性纤维机理、剂量、忌南瓜派馅）. 访问 2026-10-15.
- 氧宠博士（isdpp.com）. *猫咪"玻璃胃"怎么调理 / 经常软便怎么调理*（定时定量、慢换粮、优质动物蛋白、益生菌）. 访问 2026-10-15.
- 宠搜网（chongso.com）. *猫咪软便原因与调理 / 7天换粮法*. 访问 2026-10-15.
- 台湾宠物营养保健食品学会. *七天渐进去粮法之科学实践与临床指引*（菌群记忆、敏感猫延长10–14天）. 访问 2026-10-15.
- 东北网. *《2026中国宠物行业白皮书》喂养行为调研*（>62%宠主换粮、约四成换粮后软便）. 访问 2026-10-15.
- 猫后苑（catgarden.app, HK）. *猫咪拉肚子原因与就医判断*（7日换粮、寄生虫假阴性、便色判读、慢性>2–3周就医）. 访问 2026-10-15.
- 虾/海鲜风险多篇（ouyi89、ouyi81、dongwangask、baidu健康）. *猫吃虾风险*（虾壳几丁质难消化/梗阻、虾头组胺、高钠、生虾细菌、过敏、零食≤10%热量）. 访问 2026-10-15.
- Radiokop Animal Clinic. *Chronic diarrhoea in dogs and cats*（高消化蛋白+低脂肪 bland diet；益生菌）. 访问 2026-10-15.
- 商品评估说明：文中"京东京造 0谷物6肉8果蔬"仅为结合多多个案的客观分析，非推荐/背书，具体选粮请遵兽医建议。

免责声明：本文为科普与居家管理参考，内容综合自上述公开权威信源并标注，**不能替代执业兽医诊断与治疗。**如症状加重或出现警示信号，请立即就医。

文档版本 v2 ｜ 生成 2026-10-15 ｜ 作者：爱莉（WorkBuddy 执行型协作者） ｜ 同步：ima 中转区(KB 7475348006525608) + QQ邮箱(jaeyeonn@qq.com)